

Urgencia hipertensiva

L. Jiménez Murillo, S. Palenzuela Martín, J. M. García Quintana, M. J. Clemente Millán y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

- La *hipertensión arterial* se define como la existencia de una presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg o una presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, medidas en tres ocasiones distintas con un intervalo mayor de 1 semana, si bien la detección una sola vez de una PAS > 210 mmHg o de una PAD > 120 mmHg es suficiente para realizar el diagnóstico de esta enfermedad.
- La *urgencia hipertensiva* se define como la elevación brusca de la presión arterial, sin que exista disfunción de los órganos diana.
- Según las cifras detectadas de presión arterial, la hipertensión puede ser:
 - **Ligera (estadio 1):** PAS de 140-159 mmHg o PAD de 90-99 mmHg.
 - **Moderada (estadio 2):** PAS de 160-179 mmHg o PAD de 100-109 mmHg.
 - **Grave (estadio 3):** PAS ≥ 180 mmHg o PAD ≥ 110 mmHg.

DIAGNÓSTICO

- El diagnóstico de urgencia hipertensiva se basa exclusivamente en la detección de una elevación brusca de la presión arterial respecto a las cifras habituales del paciente.
- Clínicamente puede ser asintomática o acompañarse de síntomas generales inespecíficos, como cefalalgia, debilidad, náuseas sin vómitos o astenia, y en ningún caso hay disfunción aguda de los órganos diana. Con una anamnesis y una exploración física correctas, se distingue, en el 95% de los casos, la urgencia de la emergencia hipertensiva.
- Es importante diferenciar la verdadera urgencia hipertensiva de la pseudocrisis, que tiene lugar, en pacientes basalmente normotensos, como respuesta a determinadas situaciones, como el estrés emocional o el dolor, ya que en estas circunstancias no está indicado el tratamiento con fármacos hipotensores, sino actuar sobre la causa precipitante de la hipertensión mediante la administración de ansiolíticos o analgésicos, respectivamente. Asimismo, hay que tener presente que unas cifras de presión arterial superiores al rango normal no constituyen por sí mismas una urgencia hipertensiva si la elevación se ha producido de forma paulatina, sino que manifiestan una *hipertensión mal controlada*.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

- En el área de consultas del servicio de urgencias deben realizarse, a todos los pacientes con urgencia hipertensiva, un **electrocardiograma (ECG)** y una **radiografía posteroanterior y lateral de tórax**. Con estas exploraciones pueden detectarse alteraciones que denoten una hipertensión arterial de larga evolución, como crecimiento ventricular izquierdo (onda S en V₁ más onda R en V₅ > 35 mm) en el ECG o cardiomegalia en la radiografía de tórax.
- Si el paciente requiere ingreso hospitalario, se solicitarán, además, hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, y bioquímica sanguínea que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio y calcio.

CRITERIOS DE INGRESO

Deben ingresar en el área de observación del servicio de urgencias los pacientes que presenten una urgencia hipertensiva con factores pronósticos desfavorables (diabetes con mal control metabólico, antecedentes de ictus o de cardiopatía isquémica), en los que se sospeche un seguimiento inadecuado de las recomendaciones establecidas o en los que no sea posible realizar un control ambulatorio estrecho en las siguientes 24-48 h. El criterio de ingreso no se determina por unas cifras de presión arterial aisladas.

Recuérdese que no se debe confundir una urgencia hipertensiva con una hipertensión transitoria (falsa hipertensión) ni con una hipertensión mal controlada.

TRATAMIENTO

- Su objetivo principal es reducir la presión arterial media en un 20%, o la PAD < 120 mmHg en un período de 24-48 h. Con estos valores se asegura una mínima incidencia de hipoperfusión cerebral, coronaria y renal.
- Antes de iniciar el tratamiento con fármacos hipotensores, es necesario tener presentes las siguientes consideraciones:
 - La brusca reducción de la presión arterial por debajo de un dintel que permita la autorregulación para mantener una adecuada perfusión orgánica puede inducir una isquemia en los órganos diana. El descenso de la presión arterial a unas cifras consideradas seguras

(PAS < 210 mmHg o PAD < 120 mmHg) debe realizarse en el transcurso de varias horas. No deben intentarse reducciones más intensas (PAS < 160 mmHg o PAD < 100 mmHg), sino que los valores diana deben alcanzarse en el transcurso de días, de forma ambulatoria, ya que, en la inmensa mayoría de los casos, se trata de pacientes con hipertensión arterial esencial crónica mal controlada.

- En ningún caso, la presión arterial debe descender por debajo de las cifras habituales del paciente.
- Los fármacos antihipertensivos deben utilizarse, inicialmente, de manera aislada y en la dosis más baja recomendada. Más adelante, si la respuesta no es satisfactoria, se incrementa la dosis de forma progresiva y se asocian otros fármacos hipotensores hasta controlar las cifras de presión arterial.
- Debe descartarse cualquier enfermedad, asociada o no al proceso hipertensivo, que contraindique la administración de un determinado fármaco hipotensor.
- No debe olvidarse nunca la «regla de oro» de la hipertensión arterial: siempre se trata al paciente y no a la presión arterial.

MEDIDAS GENERALES

- En pacientes con hipertensión conocida, debe indagarse sobre las posibles causas de un control inadecuado de la presión arterial, como escaso seguimiento de una dieta hiposódica o incumplimiento del tratamiento prescrito, infradosificación del mismo, asociación inadecuada de fármacos en función de la comorbilidad del paciente, abuso de antiinflamatorios no esteroideos, corticoterapia prolongada, síndrome de apnea del sueño, enfermedad renal crónica, etc.
- El paciente debe estar en reposo, en un lugar tranquilo, apartado, en la medida de lo posible, del estrés de una sala de espera de urgencias.
- Si existe ansiedad, se administra lorazepam (comprimidos de 1 mg), en dosis de 1 mg por vía oral o sublingual.
- Si el paciente tiene dolor, se administra metamizol magnésico (cápsulas de 575 mg), en dosis de 1-2 cápsulas por vía oral.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

- Si a los 30 min de estar en reposo en un lugar relajado, y de haberle administrado ansiolíticos o analgésicos (o ambos) en caso de ansiedad o dolor, el paciente tiene unas cifras de PAS < 160-180 mmHg y de PAD < 100-120 mmHg, y estaba recibiendo tratamiento antihipertensivo, se procede al alta domiciliaria reintroduciendo su medicación si no la estaba tomando, incrementando la dosis o añadiendo otro fármaco (uno de ellos debe ser un diurético, sobre todo si el enfermo no sigue las recomendaciones de una dieta hiposódica). Si la hipertensión arterial no era conocida, no se administra ninguna medicación hipotensora, sino que se recomienda seguimiento ambulatorio en las siguientes 24-48 h para evaluar la necesidad de tratamiento antihipertensivo.
- Si, por el contrario, tras lo comentado anteriormente, las cifras de PAS son superiores a 180 mmHg o las de PAD

son superiores a 120 mmHg, debe iniciarse tratamiento antihipertensivo. Se administra uno de los siguientes fármacos por vía oral, no sublingual, cuya elección dependerá de las características de cada paciente:

- Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), como captopril (comprimidos de 25 y 50 mg), en dosis de 25 mg, que puede repetirse a los 30 min si es necesario. Inicia su acción a los 15-30 min y alcanza su máximo efecto en 1-2 h. Está contraindicado en pacientes con hiperpotasemia, insuficiencia renal, angioedema y embarazadas.
- Bloqueadores β , como labetalol (comprimidos de 100 y 200 mg), en dosis de 100 mg, que puede repetirse a las 2 h si es necesario. Inicia su acción a los 15-30 min y alcanza su máximo efecto a las 2-4 h. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, isquemia arterial periférica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o bloqueo auriculoventricular (BAV) de segundo o tercer grado.
- Si el captopril y el labetalol están contraindicados, se puede administrar uno de los siguientes fármacos por vía oral:
 - Diuréticos de asa, como furosemida (comprimidos de 40 mg), en dosis de 40 mg. Alcanzan su máximo efecto en 1-2 h. Deben evitarse si hay depleción volumétrica o hiperuricemia, y se administrarán con precaución en pacientes con cardiopatía isquémica o aneurisma disecante de la aorta.
 - Antagonistas del calcio, como amlodipino (comprimidos de 5 y 10 mg), en dosis de 5 mg. Tienen su máximo efecto a las 1-6 h. Deben evitarse en pacientes con BAV de alto grado.
 - α -agonistas, como clonidina (comprimidos de 0,15 mg), en dosis de 0,15 mg. Deben evitarse en la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia renal grave y la enfermedad del nódulo sinusal.
- Si después de la administración de una segunda dosis de captopril o labetalol las cifras de PAD continúan siendo superiores a 120 mmHg, no existe evidencia de que otras medidas terapéuticas más agresivas mejoren el pronóstico, puesto que no se ha demostrado que una reducción rápida de la presión arterial suponga un beneficio para el paciente, sino que incluso en algunos casos podría precipitar la aparición de una isquemia miocárdica o cerebral. Por ello, se recomienda pautar tratamiento por vía oral con objeto de controlar las cifras de presión arterial en las siguientes 24-48 h, con un exhaustivo control ambulatorio. Se hace de la siguiente manera:
 - Si el paciente era hipertenso conocido y estaba en tratamiento antihipertensivo, se procede tal como se ha comentado anteriormente, es decir, reintroduciendo su medicación, si no la estaba tomando, incrementando la dosis o añadiendo otro fármaco.
 - Si el paciente no era hipertenso conocido o no tenía prescrito ningún tratamiento, se administra cualquier fármaco de los cinco grupos principales (IECA, bloqueadores β , diuréticos, antagonistas del calcio o antagonistas de los receptores de la angiotensina II [ARA-II]). Una pauta inicial muy acertada puede ser

la asociación, por vía oral, de un diurético tiazídico, como la clortalidona (comprimidos de 50 mg) o la hidroclorotiazida (comprimidos de 25 y 50 mg) en dosis inicial de 25 mg/24 h, y un bloqueador β , como el atenolol (comprimidos de 50 mg), en dosis inicial de 50 mg/24 h, o un antagonista del calcio, como el amlodipino (comprimidos de 5 y 10 mg), en dosis inicial de 5 mg/24 h. Si se utiliza un ARA-II, puede administrarse losartán (comprimidos de 50 y 100 mg) en dosis inicial de 50-100 mg/24 h.

- El uso de fármacos por vía intravenosa debe restringirse para la emergencia hipertensiva (v. cap. 33) o para las situaciones de urgencia hipertensiva que, por las características clínicas del paciente (aneurisma aórtico o cerebral), puedan desembocar en una emergencia. También está indicado en las circunstancias que contraindiquen el uso de la vía oral, como la cirugía urgente o el postoperatorio inmediato. Los fármacos y las dosis se detallan en el capítulo 33, si bien el labetalol y el urapidil son los más recomendados.

Bibliografía recomendada

- Astarita A, Covella M, Vallelonga F, et al. Hypertensive emergencies and urgencies in emergency departments: a systematic review and meta-analysis. *J Hypertens* 2020;38:1203.
- Kim BS, Kim HJ, Lyu M, et al. Clinical characteristics, practice patterns, and outcomes of patients with acute severe hypertension visiting the emergency department. *J Hypertens* 2021;39:2506.
- Paini A, Tarozzi L, Bertacchini F, et al. Cardiovascular prognosis in patients admitted to an emergency department with hypertensive emergencies and urgencies. *J Hypertens* 2021;39:2514.
- Varon J, Elliot WJ. Management of severe asymptomatic hypertension (hypertensive urgencies) in adults. (Consultado el 17 de noviembre de 2021.) Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/management-of-severe-asymptomatic-hypertension-hypertensive-urgencies-in-adults?search=urgencia%20hipertensiva&source=search_result&selected-Title=1~29&usage_type=default&display_rank=1.
- Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 CC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension* 2018;71:e13.